Anamnesefragen

Was kann ich für Sie tun?
Was führt Sie zu uns?
Seit wann haben Sie diese Schmerzen?
Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?
Gibt es einen Auslöser für die Schmerzen? z. B. Haben Sie sich verletzt? Oder Haben Sie etwas Schweres getragen?
Sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen sie wieder weg?
Ist es das erste Mal, oder hatten Sie früher schon ähnliche Symptome?
Sind die Schmerzen mit der Zeit schlimmer geworden?
Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen klopfend oder stechend?
Wie stark?
Haben Sie etwas gegen die Schmerzen eingenommen oder gemacht?

Haben Sie Probleme beim Wasserlassen?
Wie oft müssen Sie zum Wasserlassen?
Welche Farbe hat der Urin? Gibt es Blut im Urin?
Riecht der Urin stark oder ungewöhnlich?
Müssen Sie auch in der Nacht zum Wasserlassen?
Haben Sie Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen?
Wie viel Urin haben Sie?
Wie viel Wasser trinken Sie täglich?
Ist der Harnstrahl unterbrochen oder dauerhaft?
Ist der Harnstrahl schwach oder stark?
Fühlen Sie Harnreste in der Blase?

Haben Sie Fieber?
Hatten Sie Schüttelfrost?
Haben Sie starkes Schwitzen in der Nacht?
Wie ist Ihr Appetit?
Haben Sie in letzter Zeit stark an Gewicht abgenommen?

Hatten Sie in der Vergangenheit schon Harnwegsinfekte?
Wie oft? (Rekurrenz)
Wurden diese mit Antibiotika behandelt? Wenn ja, welche?
Haben Sie die Antibiotika vollständig eingenommen?

Haben Sie Probleme beim Stuhlgang?
Haben Sie Übelkeit? Erbrechen?
Haben Sie Völlegefühl? Blähungen?
Haben Sie Sodbrennen? Saures Aufstoßen?

Wann hatten Sie das letzte Mal Ihre Monatsblutung?
Kann das sein, dass Sie schwanger sind?
Gehen Sie regelmäßig zur Frauenärztin / zum Frauenarzt?
Wann waren Sie das letzte Mal bei Ihrer Frauenärztin / Ihrem Frauenarzt?
Ist alles in Ordnung?
Haben Sie ungewöhnlichen Ausfluss oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr?
Benutzen Sie Verhütungsmittel wie Diaphragma?

Am Ende des Gesprachs Aufklarung

Ich habe einen Verdacht auf **Harnsteinleiden**.
Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.
Ich werde zuerst körperliche Untersuchung machen, dann Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich eine Urinuntersuchung und eine Bauchultraschall durchführen. Wissen Sie, was das ist?
Sobald die Ergebnisse vorliegen, bespreche ich mit meinem Oberarzt, dann komme ich zu Ihnen, erzähle Ihnen alles

Sonographie:
Ein Ultraschall des Bauchraums ist eine schmerzfreie und strahlenfreie Untersuchung, die etwa 15 Minuten
dauert. Ein Gel wird auf Ihren Bauch aufgetragen und Ihre inneren Organe mit einer Sonde beobachtet.
Urinprobe (Mittelstrahlurin):
Für die Urinuntersuchung geben Sie eine kleine Menge Urin/Wasser in einem sauberen Becher.Dafür waschen Sie zuerst die Genitalregion (= Geschlechtsbereich) mit einem Reinigungstuch. Lassen Sie
den ersten Teil des Urins in die Toilette laufen, dann den Mittelstrahl des Urins im Becher, und lassen Sie
den Rest wieder in die Toilette. Dies hilft genauere Testergebnisse zu haben.

Haben Sie noch Fragen an mich?

ARZT-ARZT GESPRACH

Guten Tag, Herr Oberarzt, Frau Oberärztin.
Mein Name ist Sümeyra Firat. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen.
Bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen noch etwas Wichtiges mitteilen:
Ich habe einen Anruf aus dem Labor erhalten. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Müller einen Kaliumwert von **2,6 mmol/L** hat. Dieser Wert ist **deutlich erniedrigt** und entspricht einer **Hypokaliämie**.

Jetzt berichte ich über den Fall meiner Patientin.
Es geht um Frau Sabine Wagenbach. Sie ist 45 Jahre alt, am 14.10.1978 geboren, 168 cm groß und wiegt 86 kg.
Frau Wagenbach stellt sich bei uns wegen seit anderthalb Stunden bestehender Schmerzen in der rechten Flanke vor.
Laut Angaben der Patientin sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten.
Sie berichtet, dass die Schmerzen in den rechten Unterbauch ausstrahlen und die Schmerzintensität bei 7/10 auf der Schmerzskala liegt.
Nach Angabe der Patientin sind die Schmerzen stechend, kolikartig, progredient und persistierend.

Begleitend klagt sie über ungemessenes Fieber, Übelkeit, Schweißausbrüche und Hämaturie.
Vegetativ-anamnestisch ergab sich lediglich Inappetenz.
Die gynäkologische Anamnese war unauffällig. Ihre letzte Periode war vor 14 Tagen, und eine Gravidität wurde verneint.
Bei der Vorerkrankungsanamnese erwähnte sie Morbus Crohn seit 20 Jahren und Z. n. lokalisierte Resektion eines Teils des Dünndarms im Rahmen des Morbus Crohn.
Bei der Medikamentenanamnese ergab sich die Einnahme von Prednisolon/Budesonid in unklarer Dosis bei Schüben des Morbus Crohn sowie Ergänzungsstoffe wie Mineralien ab und zu.
Allergien wurden verneint; es besteht jedoch eine Glutenunverträglichkeit sowie eine Empfindlichkeit gegenüber fettigem Essen.
Die Noxenanamnese war unauffällig. Nikotin-, Alkohol- und Drogenkonsum wurden verneint.
Die Familienanamnese ergab Lungenfibrose beim Vater, Colitis ulcerosa bei der Mutter und Zwangsstörungen bei der Schwester.
Sozialanamnestisch ist sie Gärtnerin von Beruf, verheiratet und wohnt mit ihrem Mann zusammen; sie hat einen Sohn.

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Urolithiasis hin.
Kolikartige Flankenschmerzen mit Ausstrahlung in den rechten Unterbauch, Übelkeit, Hämaturie und die Vorgeschichte mit Morbus Crohn sprechen dafür.
Differenzialdiagnostisch kommen Pyelonephritis, ein akuter Schub des Morbus Crohn, eine Divertikulitis, eine Appendizitis sowie eine Adnexitis, extrauterine Gravidität und Ovarialtorsion in Betracht.
Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, die Vitalparameter überwachen und Blut für das Labor abnehmen.
Im Labor würde ich ein großes Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, β-HCG, einen Urinstatus und eine Urinkultur kontrollieren lassen.
Anschließend werde ich eine Sonographie der Nieren, ggf. ein Röntgen-Abdomen und ggf. ein CT-Abdomen durchführen und ein Konsil in der Urologie oder Nephrologie anfordern.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, empfehle ich folgende Therapie:
Die Patientin sollte stationär aufgenommen werden.
Die Patientin sollte eine Infusionstherapie und eine symptomatische Behandlung wie Analgetika (Metamizol/NSAR bis Morphin) sowie Spasmolytika erhalten.
Die Behandlung richtet sich nach Größe, Lage und Komplikationen des Steins. Bei kleinen Nierensteinen bis etwa 5–6 mm erfolgt meist eine konservative Therapie mit viel Flüssigkeit, Schmerzmitteln und ggf. Tamsulosin zur Erleichterung des Steinabgangs.

Bei größeren Steinen oder bei Komplikationen werden interventionelle Verfahren wie ESWL, Ureterorenoskopie oder perkutane Nephrolithotomie eingesetzt.

Bei Fieber und Harnstau ist eine sofortige Drainage und Antibiotikatherapie notwendig.

Reaktionen:

Darf ich nach der Einnahme von Medikamenten nach Hause? Soll ich hierbleiben? Pyelonephritis - Diskusprolaps

- Ja, Das kann ich im Moment noch nicht wissen, wir warten auf die Befunde der Untersuchung und können dann entscheiden.
- Kann jemand anderes Ihre Sachen mitbringen?
- Wir sind hier, um Ihnen zu helfen.
- Ich weiß, niemand bleibt gerne im Krankenhaus

- Es ist nicht gefährlich, keine Sorge, aber es wäre besser, wenn Sie hier bei uns bleiben, damit wir schnell reagieren können, wenn sich bei Ihnen etwas Neues entwickelt.

Ich habe Übelkeit und Schmerzen, könnten Sie mir helfen? Pyelonephritis - Cholelithiasis

- Ja, wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Ich verstehe, dass Sie starke Schmerzen haben, aber ich brauche einige weitere Informationen. Könnten Sie die Schmerzen noch ein bisschen aushalten, bis unser Gespräch zu Ende ist?
  Prima! Auf jeden Fall wäre das besser für die Diagnose. Ich versuche möglichst schnell zu beenden.

- Frau Breiterweg, ich merke, dass Sie starke Schmerzen haben, aber bevor die Untersuchungen kann ich Ihnen leider kein Schmerzmittel geben. Das ist wichtig für die richtige Diagnose. Aber ich versuche das Gespräch ganz schnell zu beenden. Bitte halten Sie die Schmerzen für kurze Zeit aus.

Die Patientin hat vor 2 Wo. ohne Rezept Antibiotikum eingenommen. Pyelonephritis

- Ich verstehe, dass die Medikamente Ihnen bereits geholfen haben. Aber bitte nehmen Sie keine Medikamente ohne ärztlichen Rat ein. Das kann sehr gefährlich sein und Nebenwirkungen verursachen.

Intravenöse Pyelographie (IVP)

- Eine intravenöse Pyelographie (IVP) ist eine Untersuchung, die verwendet wird, um die Nieren, Harnleiter und Blase mittels Röntgenaufnahmen sichtbar zu machen. Bei einer IVP wird ein Kontrastmittel in eine Vene in Ihrem Arm injiziert und dann werden Röntgenaufnahmen gemacht, während das Kontrastmittel durch Ihre Nieren und Harnwege fließt. Auf diese Weise können Veränderungen oder Blockaden in den Harnwegen festgestellt werden.

23. Urolithiasis (neue)

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

- Sabine Wagenbach
- 45 J.
- 14.10.1978
- 1,68m
- 86 kg

-Hauptbeschwerde

- Schmerzen in der rechten Flanke
  - Seit anderthalb Stunden
  - plötzlich auftretende: Haben Sie sich verletzt? Haben Sie etwas Schweres getragen?
  - stechende kolikartige (wehenartig)
  - mit Ausstrahlung in den rechten Unterbauch
  - progredient und persistierend
  - NRS: 7/10
  - keinen Auslöser oder keine Medikamente dagegen eingenommen
  - keine ähnliche Beschwerden früher

-vegetative Symptomatik

- Ungemessenes Fieber seit heute Morgen (~~ich fühle mich fiebrig, aber ich kann nicht klar sagen, ob es Fieber gab.~~) Kein Problem, wir werden sie hier messen.
- Übelkeit
- Schweißigkeit
- Dunkler/rot Urin (hat rote Farbe - War es Blut? Ich bin mir nicht sicher.)
  - War Ihr Urin wie Altbier? Wie viel Wasser trinken Sie pro Tag?
- Inappetenz

-gyn

- Letzte Periode vor 14 Tagen, normalerweise regelmäßig.
- Besucht zweimal im Jahr den Frauenarzt. Ist es möglich, dass Sie schwanger sind? Verhüten Sie?

-Vorerkrankungen

- Morbus Crohn seit 20 Jahren (CED = chronische entzündliche Darmerkrankung)

-Vor-OPs

- Vor 10 J. lokalisierte Resektion eines Teils des Dünndarms im Rahmen von Morbus Crohn, Dünndarmabschnittentfernung, komplikationslos (Mir wurde ein Teil meines Darms entfernt)

-Medikation

- Prednisolon / Budesonid, unklare Dosis Tbl., b.B., gegen Morbus Crohn – bei Schüben
- Ergänzungsstoffe wie Mineralien Tbl., ab und zu

-Allergien

- Glutenunverträglichkeit – krampfartige Bauchschmerzen
  - Auf ein paar Lebensmitteln muss ich auch verzichten.
  - Wie was?
  - fetthaltiges Essen

-Noxen

- Nichtraucherin, Nein sehe ich so aus??
- trinkt kein Alkohol
- kein Drogenkontakt

-Sozialanamnese

- Gärtnerin in einer Gärtnerei, zufrieden,
- Verheiratet
- hat einen Sohn - 16J, gesund

-Familienanamnese

- Vater (68J.) Z.n. COVID-19 vor 2 Jahren, leidet er noch darunter, Lungenfibrose, er bekommt immer Luftnot bei jeder Bewegung
  - Das muss sehr schwer für ihn sein, und es tut mir leid zu hören, dass er so sehr darunter leidet.
- Mutter (66 J.), seit langem Colitis ulcerosa (chronisch-entzündliche Darmerkrankung (CED))
- Schwester, 42J, sie ist besessen davon, den Dreck wegzuräumen und alles zu putzen, wo immer sie ihn findet. Ist sie wirklich psychisch krank?
  - = **Zwangsstörungen** (OCD: obsessive - compulsive disorder) bezüglich der Sauberkeit
  - ugs. **Putzfimmel** (cleaning obsession) besetzen * (Sauberkeit besetzen)
  - Ich kann verstehen, dass Sie sich Sorgen machen. Es wäre gut, wenn sie mit einem Spezialisten darüber sprechen könnte, um die beste Unterstützung zu erhalten.

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, ich bin nun mit meinen Fragen fertig.
Ich habe einen Verdacht auf **Harnsteinleiden**. Aber das bleibt nur eine Vermutung, wir sollen weitere Untersuchungen durchführen, um dies zu bestätigen. Ich werde zuerst Ihren Körper untersuchen, dann Ihnen etwas Blut abnehmen. Danach werden wir einen Bauchultraschall und eine Urinuntersuchung machen. Wissen Sie, was das ist?

Sonographie:
Ein Bauchultraschall ist eine schmerzfreie und strahlenfreie Untersuchung, die etwa 15 Minuten dauert. Ein Gel wird auf Ihren Bauch aufgetragen und Ihre inneren Organe mit einer Sonde vorsichtig beobachtet.

Urinprobe (Mittelstrahlurin):
Für die Urinuntersuchung geben Sie eine kleine Menge Urin/Wasser in einem sauberen Becher.

Dafür waschen Sie zuerst die Genitalregion (= Geschlechtsbereich) mit einem **Reinigungstuch**. Lassen Sie den ersten Teil des Urins in die Toilette laufen, dann den Mittelstrahl des Urins im Becher, und lassen Sie den Rest wieder in die Toilette. Dies hilft genauere Testergebnisse zu haben.

-Fragen

- Soll ich hierbleiben? Wir werden noch einige Untersuchung durchführen, um meinen Verdacht zu bestätigen. Wenn meinen Verdacht richtig ist, sollen Sie hierbleiben ja, um die richtige Therapie zu bekommen.
- Was ist mit mir los? Sie haben wahrscheinlich einen **Nierenstein**, der Ihre Symptome verursacht.
- Was ist ein Stein? Ein Stein ist eine **feste Ansammlung von Mineralien**, die sich in den Nieren oder Harnwegen bilden. Das kann eine Komplikation Ihres Morbus Crohn sein.
- Wie viel muss ich warten? Vielleicht einige Stunden, bis wir alle Ergebnisse haben, dann noch einige Stunden für die richtige Behandlung.
- Mein Mann ist auf Geschäftsreise, er soll auch Bescheid wissen und mein Sohn ist allein zuhause / ich soll meinen Sohn von der Schule abholen. Sie können gerne Ihren Mann und Ihren Sohn informieren und **sehen, ob jemand anderes helfen kann**.

Arzt-Arzt-Gespräch

Guten Tag. Mein Name ist Masson. Ich arbeite seit kurzem als Assistenzärztin in der Ambulanz/Notaufnahme.

Es geht um **Frau Sabine Wagenbach, 45** Jahre alt, die in gutem AZ (Allgemeinzustand) und adipösem EZ (Ernährungszustand) gekommen ist.

Sie beschreibt Ihre aktuellen Symptome wie folgt: seit anderthalb Stunden stechende und kolikartige Schmerzen in der rechten Flanke, die in den rechten Unterbauch ausstrahlen. Die Schmerzen haben plötzlich begonnen und sind seitdem progredient und persistierend. 7 von 10 auf einer Schmerzskala.

Begleitend sind seit heute Morgen ungemessenem Fieber, Nausea, Schweißausbrüche, Inappetenz. Und sie hat rote Urin bemerkt. **Ansonsten ist die vegetative Anamnese unauffällig.**

Ihre letzte Periode war vor 14 Tagen und eine Gravidität wurde verneint.

Sie leidet seit 20 Jahren an Morbus Crohn und nimmt Prednison bei Schüben ein. Sie hat vor 10 Jahren eine lokalisierte Resektion des Dünndarms bekommen.

Die Patientin hat Glutenintolerenz und verzichtet fetthaltiges Essen.

In der Familienanamnese gibt es Colitis ulcerosa.

Das wäre zunächst dem Relevanten.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Urolithiasis / **Nephrolithiasis**. Als Differentialdiagnosen sind zu nennen, akuter Schub von Morbus Crohn, Pyelonephritis und extrauterin Gravidität (oder Adnexitis / Ovarialtorsion usw.).

Als erstes werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen (**Nierenlagerklopschmerzen**); dann halte ich eine Laboruntersuchung mit Bestimmung: gr. BB, Entzündungsparameter, Leber-Nierenwerte, E-lyte, **Urinstatus** und **Urinsediment, β-HCG**.

Anschließend ist eine abdominelle Sonographie durchzuführen. Ggf. Urinkultur, Abdo-CT und Urographie.

Ich werde sie stationär aufnehmen.

Als <u>initiale Therapie</u> empfehle ich **Analgetika** (Metamizol (analgetikum + antispasmolitik), NSAR bis Morphin, wenn das nicht reicht) und eine **Flüssigkeitszufuhr** per Infusion.
Als <u>kausale Therapie</u> schlage ich eine Behandlung vor, die von der Größe des Steins hängt:

- einen **Alphablocker** für einen Stein von weniger als 5 Millimetern (für eine spontane Passage),

- *Tamsulosin*
- eine **ESWL** (= extrakorporale Stoßwellenlithotripsie) für einen Stein von mehr als 5 Millimetern,
  - *nicht-invasive Methode zur Zertrümmerung der Steine*
- und eine **perkutane Nephrolithotomie** für einen Stein von mehr als 1 Zentimeter.

Sind Sie mit meinem /diesem Vorgehen einverstanden?

Morbus Crohn'da özellikle terminal ileum tutulumunda safra asitleri yeniden emilimi bozulur. Yağ asitleri emilemeyince bağırsakta kalsiyum bağlar. Normalde kalsiyum + Oksalat diyetle alınır. Kalsiyum bağlanınca oksalat emilir, idrarda oksalat artar ve kalsiyum oksalat taşı oluşur.

-Fragen

Welche Komplikationen des Morbus Crohn wissen Sie? Im Anus was besonders? komplexe perianale Fisteln

Bei Morbus Crohn, insbesondere bei ilealem Befall oder nach Ileumresektion, kommt es zu Fettmalabsorption. Freie Fettsäuren binden Kalzium, sodass Oxalat vermehrt resorbiert wird (enterische Hyperoxalurie), was das Risiko für Kalziumoxalatsteine erhöht.

- Intestinale:
  - Mechanischer Ileus
  - **Fisteln** (kutan, enteroenteritisch, enterovesikal, enterovaginal, peranal, rektal)
  - **Abszesse** (intra- retroperitoneale), Aphthous ulcers (Mundaphten)
  - intestinale **Blutungen**
  - Toxisches Megakolon (häufiger bei Colitis ulcerosa)
  - **Colonkarzinom**
  - **Malabsorptionssyndrome** kann Megaloblastäre Anämie, Osteoporose und Osteopenie, Gallensteine, Urolithiasis führen
- extraintestinale Manifestationen von Morbus Crohn (50% der Patienten)
  - Arthralgien und Arthritiden
  - Erythema nodosum und Pyoderma gangrenosum
  - Rosazea, Uveitis

Was ist relevant in der FA? Die Colitis ulcerosa

Was hat die Schwester? umg. „Putzfimmel" = sie hat das Bedürfnis, ihre Umgebung konstant sauber und ordentlich zu halten.

Ein Putzfimmel ist nicht immer pathologisch aber in extremen Fällen kann es eine **Zwangsstörung** (TOC) sein. Es kann erforderlich sein, einen Psychiater zu besuchen (wenn das tägliche oder soziale Leben gestört ist).

Wenn ein Stein in der Urethra ist, wo genau fühlt der Patient die Schmerzen? Unterbauchschmerzen in der Mitte

Was sind die häufigsten Stoffe des Steins? Calciumoxalat, Harnsäurehaltige Steine, Calciumphosphat

Achtung: Infektstein (Struvit), Cystinstein (seltenen Stoffwechselerkrankung, der Cystinurie) = diese Steine können nicht mit ESWL behandelt werden.

Wenn der Stein in der Blase liegt, was machen wir? Überwachung (keine ESWL oder Uroskopie oder urologisches Konsil)

Hafif ağrılarınıve → alnalı böbrek

Die Nicht-Opioide **Metamizol** (= Novaminsulfon) und **Indometacin** senken neben ihrer analgetischen Wirkung auch den erhöhten intraluminalen Druck (Ursache des Kolikschmerzes). Metamizol wirkt zusätzlich spasmolytisch und antinozizeptiv auf den Harnleiter und ist daher Mittel der ersten Wahl bei starken Schmerzen. Metamizol (1g) und Diclofenac (75 mg) sind in der Wirkung äquivalent.

Urolithiasis = Konkrementen (Harnsteinen) in den Harnwegen (Nierenbecken, Ureteren, Harnblase, Urethra)

- Nephrolithiasis: Stein im Hohlsystem der Niere (Nierenstein)
  - Schmerz: Flanke / Rücken
  - *Ausstrahlung: Bauch*

Hohlsystem – Toplayıcı Sistem

- Ureterolithiasis: Stein im Harnleiter (Harnleiterstein)
  - Schmerz: Unterbauch in der Mitte, kolikartige (= wellenartig)
  - Ausstrahlung: Leiste, Genitalbereich
- Zystolithiasis: Stein in der Harnblase (Blasenstein) ❑ Überwachung (Flüssigkeit, ggf. Alphablocker)
  - Schmerz: Unterbauch, superpubisch
  - Symptome: brennende Schmerzen (Dysurie), häufiger Harndrang (Pollakisurie)
- Urethralithiasis: Stein in der Harnröhre
  - Schmerz: Perineum, Harnröhrenende
  - Symptome: Dysurie

Pathophysiologie: Der Urin ist übersättigt und fehlen gleichzeitig antilithogene Einflussfaktoren ❑ Bildung und Aggregation von Kristallen. Arten von Nierensteinen: (*Die Ursachen hängt von der Zusammensetzung ab*)

- *Calciumsteine* (Calciumoxalat, Phosphat): die häufigsten
  - Dehydratation (zu wenig Wasseraufnahme)
  - Hyperparathyreoidismus (durch erhöhte Kalziumspiegel im Blut und Urin)
  - Ernährung reich an Oxalat (grünes Blattgemüse, Nüsse, Schokolade)
  - Genetische Prädisposition
  - Stoffwechselstörungen: Erhöhte Kalziumausscheidung im Urin ✓
  - Malabsorptionssyndrome (z.B Morbus Crohn*)
- *Harnsäuresteine*: wenn der Urin zu sauer ist
  - Gicht
  - Dehydratation
  - Ernährung reich an tierischem Eiweiß
- *Struvitsteine* (Ammoniumphosphat und Magnesium) können nicht mit ESWL behandelt werden
  - Bakterielle Harnwegsinfektionen (Proteus, Klebsiella ❑ produzieren Urease)
  - Anatomische Anomalien
- *Cystinsteine*: selten
  - Cystinurie (= genetische Störung)

*Mechanismen der Nierensteinbildung bei Morbus Crohn:

1) *Malabsorption von Fetten*, insbesondere wenn das Ileum betroffen ist ❑ Die nicht absorptierten Fette binden sich im Darm an Calcium (sich normal an Oxalat zu binden) ❑ Es bleibt mehr Oxalat in Darm frei ❑ Dann mehr über den Urin ausgeschieden ❑ Hyperoxalurie = ein Zustand begünstigt die Ausfällung von Calciumoxalatsteinen
2) *Chronische Diarrhö*:
   - Dehydration und vermindertes Urinvolumen ❑ erhöht die Konzentration von Substanzen
   - Verlust von Bicarbonaten ❑ metabolische Azidose ❑ erhöhte Ausscheidung von Calcium im Urin
3) *Chirurgische Komplikationen*: Die Entfernung von Darmabschnitten kann die Malabsorption verschlimmern

Klinik: (Harnsteine sind asymptomatisch, bis sie eine Obstruktion der Harnwege verursachen oder Schaden anrichten, indem sie sich lösen)

- Harnleiterkolik = Leitsymptome: wehenartige Schmerzen, die meist im UB, Rücken, Skrotum bzw. Schamlippen ausstrahlen
- Begleitend: schmerzbedingte Emesis, reflektorisch Subileus, Oligurie +/- Hämaturie

Komplikationen: bei Harnstau ❑ Infektion, Hydronephrose, Fornixruptur, Urosepsis (mit Gram -)

Diagnostik:

- *Urinstatus* (= Urinteststreifen)
  - Hämaturie, Leukozyturie, *pH (sauer mit Harnsäuresteinen / alkalischer mit Struvitsteinen)*
- *Urinsediment*

- o unterschiedliche Kristalle
- *Abdo-Sonographie*
  - o Darstellung der Steine
    - Hyperechogen mit einem deutlichen Schallschatten dahinter
    - Gut definierte, klare und meist runde / ovale Form
    - Können bewegen, wenn der Patient die Position ändert
  - o Ggf. Dilatationen (Hydronephrose)
  - o Ggf. Verdickung der Blasenwand
- Ggf. Urinkultur, Abdo-CT, Nierenleeaufnahme, Urographie

Therapie:

- Initiale / Symptomatische:
  - o Analgetikum: NSAR (Iboprofen oder Diclofenac) oder Novaminsulfon, Opioide (Morphine) wenn das nicht reicht
  - o Flüssigkeitszufuhr
  - o Antiemetika
- Kausale
  - o *Steine < 5 mm*:
    - Spontane Passage (erhöhte Flüssigkeitzufuhr und körperliche Aktivität)
    - +/- Alphablocker (Tamsulosin) können gegeben werden, um die Harnleiter zu entspannen
  - o *Steine 5-10 mm*:
    - Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) = nicht-invasive Methode zur Zertrümmerung der Steine, die auf natürlichem Weg gehen
    - *oder* Ureteroskopie = flexibles Endoskop wird durch die Harnröhre in den Harnleiter eingeführt, um Steine direkt zu entfernen oder mit einem Laser zu zerkleinern.
  - o *Steine > 10 mm*:
    - Ureteroskopie
    - oder perkutane Nephrolithotomie (PCNL)= minimalinvasive chirurgische Entfernung (kleiner Schnitt gemacht in den Rücken und Nephroskop eingeführt)
  - o *bei Versagen oder Komplikationen*: Chirurgische Steinentfernung

Begriff — alkoholischer Geruch der Atemluft

Was ist Fahne? eine Flagge (Landsymbol) / Alkoholfahne = ~~Mundgeruch~~ nach Alkoholkonsum

Welche andere Krankheit verursacht einen bestimmten Mundgeruch? Diabetische Ketoazidose (DKA) oder längere Nahrungskarenz (Azetongeruch von Nagellackentferner)

(Ojeazoner)

Was ist Mumps? Parotitis epidemica, ugs. Ziegenpeter / eine ansteckende, mit Fieber verbundene Infektionskrankheit durch Virusinfektion. Sie befällt vor allem die Ohrspeicheldrüsen.

- Häufige Komplikationen: Meningitis (Hirnhautent.) und Orchitis (Hodenent.) —> Unfruchtbarkeit
- Ursache: Mumpsvirus, gehört zur Paramyxoviridae ✓

Welche anderen Drüsen kann es beeinflussen? Pankreas und Hoden

Der Unterschied zwischen Arterien und Venen?

- Arterien = Blutgefäße, die sauerstoffreiches Blut vom Herzen wegführen
  - o Sie haben eine dicke elastische Wand, in ihnen wird das Blut mit hoher Geschwindigkeit und mit hohem Druck in den Blutkreislauf gepresst
- Venen = Blut zum Herzen zurückleiten, oft sauerstoffarm und mit Kohlendioxid angereichert
  - o Sie haben eine dünnere Wand

Was bedeutet "nicht alle Tassen im Schrank haben"? jemand ist nicht ganz bei Verstand sein oder ein bisschen verrückt sein

abfälliges gemeinte Umschreibung von Zahl kaum dran

Bei dem ist was da dg.!

Was ist Phimose? Vorhautverengung (wenn das Präputium nicht über die Glans penis zurückgeschoben ist)

Was ist Budesonid? ein synthetisches Glucocorticoid, Indikationen:

- Asthma bronchiale, COPD
- nichtinfektiöser Rhinitis (wie Heuschnupfen = Rhinitis allergica), Nasenpolypen,
- CED = entzündlichen Darmerkrankungen (Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa)
- eosinophiler Ösophagitis
- Krupp-Syndrom (Laryngitis subglottica)

Was ist Morbus Crohn? eine CED, führt zu einer chronisch-granulomatösen Entzündung, die gesamten Verdauungstrakt von der Mundhöhle bis zum After könnte theoretisch betroffen sein. Bevorzugt befallen sind terminales Ileum, das Kolon.

Was ist der Unterschied zwischen Arthrose und Arthritis?

- Arthrose ist eine degenerative Gelenkerkrankung (**Gelenkverschleiß**) durch Überbelastung, angeborene oder traumatisch bedingte
- Arthritis ist eine **entzündliche** Gelenkerkrankung, die infektiös, rheumatisch, reaktiv oder mechanisch induziert sein kann.

Was ist ÖGD?

- **Ösophagogastroduodenoskopie** (= Magenspiegelung)
- **Öffentlicher Gesundheitsdienst** ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein Bereich des jeweiligen Gesundheitswesens. Sein Ziel ist der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung (Public Health).

Was ist das Boerhaave-Syndrom? = die spontane Ruptur aller Wandschichten des Ösophagus (++ distale Drittel), die meist durch schwere Erbrochenen oder Husten auftreten kann (häufiger bei Patienten mit Essstörungen z.B. Bulimie oder Alkoholsucht).

Klinik: explosionsartiges Erbrechen (mit Hämatemesis), starker Retrosternalschmerz (= „Vernichtungsschmerz") und Haut- oder Mediastinalemphysem

Diagnostik:

- KU: Abwehrspannung im Oberbauch, zervikofaziales Hautemphysem
- Ösophagographie: Cave: nur wasserlösliches KM (Gastrographin)

Therapie: intensivmedizinischer Versorgung, Thorakotomie mit Breibandantibiotika

Urolithiasis

- **Patient/ Patientin Datum (Vorname, Name, Geb.-Datum)**

Name: Sabine Wagenbach
Alter: 45 Jahre (geb. am 14.10.1978)
Größe: 1,68 m
Gewicht: 86 kg

- **Aufnahmegrund/ Diagnose (stichwortartig)**

Hauptbeschwerde:

- Seit 1,5 Stunden plötzlich aufgetretene, persistierende, progrediente, stechende, kolikartige, rechtsseitige Flankenschmerzen mit Ausstrahlung in das rechte Hypogastrium.
- Die Schmerzintensität: 7/10 auf der NRS
- Auslöser: Keine
- Lindernde Faktoren: Keine
- Verstärkende Faktoren: Keine
- Begleitsymptome:
  Hämaturie / dunkler Urin

V/A:

- Inappetenz
- Nausea ohne Emesis
- Fieber: seit heute Morgen, unangemessen
- schmerzbedingte Dyssomnie

G/A:

Letzte Menstruation vor 14 Tagen, regelmäßig

V/E:

Morbus Crohn, seit 20 Jahren

M:

Prednisolon / Budesonid, unklare Dosis, Nur bei Schüben von Morbus Crohn
Ergänzungsstoffe wie Mineralientabletten (b.B.)

Vor-op:

Dünndarmresektion vor 10 Jahren, komplikationslos.

- **Allergien/ Unverträglichkeiten:**

Glutenunverträglichkeit (krampfartige Bauchschmerzen)

- **Genussmittel/ Drogen:**

- Nikotinkonsum: Nichtraucherin
- Alkoholkonsum: wurde verneint
- Drogenkonsum: wurde verneint

- **Sozialanamnese:**

Gärtnerin in einer Gärtnerei
verheiratet

ein gesunder Sohn

- **Familienanamnese:**
  Vater (68 J.), Z.n. COVID-19 vor 2 J., Belastungsdyspnoe (Lungenfibrose)
  Mutter (66 J.) , Colitis ulcerosa.
  eine Schwester (42 J.) , (V.a. Zwangsstörung)

- **Verdachtsdiagnose:**
  Urolithiasis

- **Differentialdiagnose**
  Akute Pyelonephritis
  Ovarialzystenruptur
  Akuter schub von Morbus Crohn

- **weitere Diagnostik**
- KU
- Labor: großes BB - CRP -BSG - BZ - Leberwerte - Nierenwerte
- Urinstatus
- Sono Abdomen
- Ggf. Röntgen Abdomen
- Ggf CT Abdomen
- Urologisches Konsil

- **Therapievorschläge**
- Ambulante Behandlung
- Analgetikum
- Spasmolytika
- ESWL (bei Steingrößen von 5-20 mm)
- perkutane Nephrolithotomie (bei Steinen größer als 2 cm)

Patientin

Sabine Wagenbach

45 J.

* 16.10.1978

1,68 m 86 kg

UROLITHIASIS

Hauptbeschwerden

- seit 1,5 Stunden bestehende, plötzlich aufgetretene, persistierende, progrediente, stechende, koliartige Schmerzen im linken Flanken mit Ausstrahlung in den linken Unterbauch
- Auslöser: keine
- die Schmerzintensität: 7/10 auf der NRS
- verstärkende Faktoren: keine
- lindernde Faktoren: keine

Begleitsymptome

- Übelkeit seit 1,5 Stunden
- dunkler Urin wie Altbier
- Durchfall (1 Mal, heute Morgen, wässrig, ohne Blut)
- ungemessenes Fieber

vegetative Anamnese

- Hypohydrose

gynekologische Anamnese

- letzte Periode vor 14 Tagen

Vorerkrankungen

- Morbus ~~Chron~~ Crohn seit 20 Jahren (letzte Schub vor 6 Monaten)

OP

- Resektion eines Teils des Dünndarms vor 10 Jahren im Rahmen von Morbus Crohn (komplikationslos)

Medikamente

- Ergänzungskost wie Mineralientabletten z.B.
- Prednisolon oder Budesonid unklare Dosis bei Schüben des Morbus Crohns

Allergien/Unverträglichkeiten

- Glutenunverträglichkeit (krampfartige Bauchschmerzen)
- Empfindlichkeit gegen fettiges Essen (krampfartige Bauchschmerzen)

Genussmittel

Nikotinkonsum → Ø
Alkoholkonsum → Ø
Drogenkonsum → Ø

Sozialanamnese

- Beruf: Gärtnerin
- verheiratet
- einen Sohn (gesund)

Familienanamnese

- Vater: Lungenfibrose / 2in. Covid19 vor 2 J. Belastungsdyspnoe
  Mutter: Colitis Ulcerosa
  Schwester → V.a. Zwangsstörungen

Verdachtsdiagnose

Urolithiasis

Differentialdiagnose

akute Pyelonephritis
Akuter Schub des Morbus Crohns
Adnexitis

weitere Procedere

- KV
- Vitalparameter,
- Labor: BB, Entzündungsparameter, Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytwerte, Urinstatus, Urinkultur
- Sonographie-Abdomen
- Röntgen Abdomen
- ggf. CT-Abdomen
- urologisches Konsil

Therapie

- stationäre Aufnahme
- Flüssigkeitszufuhr
- Elektrolysubstitution
- Analgetikum
- Spasmolitikum
- Antiemetikum
- ggf. ESWL

Rosazea ist eine chronische entzündliche Hauterkrankung des Gesichts mit Rötung, Teleangiektasien und papulopustulösen Läsionen, die durch Trigger wie Sonne oder Alkohol verschlechtert wird.

Pyodema gangrenosum ist eine seltene, schmerzhafte, neutrophile Dermatose mit rasch progredienten nekrotischen Hautulzera, häufig assoziiert mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen

(schwul – lesbisch)

Urinstatus → pH niedrig bei Harnsäuresteinen — erhöht bei Struvitsteinen

Proteinurie
Hämaturie
Erythrozyten
Leukozyten
Nitrit (+)

✓ Bei Pyelonephritis hat der Patient meist Fieber und Brennen beim Wasserlassen, während bei Urolithiasis die Schmerzen plötzlich, kolikartig und ohne Fieber.

Bei Pyelonephritis ~~ist~~ sind die Schmerzen dumpf, konstant und in der Flankenregion lokalisiert. Sie werden häufig durch Klopfen verstärkt.

✓ Mittelstrahlurin bedeutet, dass man beim Wasserlassen den mittleren Teil des Urins in einem sauberen Becher auffängt, um Verunreinigungen zu vermeiden.

Das liegt daran, dass

benim nedeni bu / bu sun-da sonucta

Das liegt daran, dass ich krank bin.
(Benim nedeni benim hasta olmam.)

verzichten auf → (Akkus.) Kaçınmak

Zwangsgedanken – Obsesyon
Zwangshandlungen – Tekrarlayan davranış } Zwangsstörung

Genussmittel

Nikotinkonsum → ∅
Alkoholkonsum → ∅
Drogenkonsum → ∅

Sozialanamnese

- Beruf: Gärtnerin
- verheiratet
- einen Sohn (gesund)

Familienanamnese

- Vater: Lungenfibrose / 2m. Covid-19 vor 2 J. Belastungsdyspnoe
  Mutter: Colitis Ulcerosa
  Schwester → V.a. Zwangsstörungen

Verdachtsdiagnose

Urolithiasis

Differentialdiagnose

akute Pyelonephritis
Akuter Schub des Morbus Crohns
Adnexitis

weitere Procedure

- KU
- Vitalparameter,
- Labor: BB, Entzündungsparameter, Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytwerte, Urinstatus, Urinkultur
- Sonographie-Abdomen • Röntgen Abdomen
- ggf. CT-Abdomen
- urologisches Konsil

Therapie

- stationäre Aufnahme
- Flüssigkeitszufuhr
- Elektrolytsubtitution
- Analgetikum
- Spasmolitikum
- Antiemetikum
- ggf. ESWL

Rosazea ist eine chronische entzündliche Hauterkrankung des Gesichts mit Rötung, Teleangiektasien und papulopustulösen Läsionen, die durch Trigger wie Sonne oder Alkohol verschlechtert wird.

Pyodema gangrenosum ist eine seltene, schmerzhafte, neutrophile Dermatose mit rasch progredienten nekrotischen Hautulzera, häufig assoziiert mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen

(schwul → escinsel)

Urinstatus → pH niedrig bei Harnsäuresteinen — erhöht bei Struvitsteinen

Proteinuri
Hämaturie
Erythrozyten
Leukozyten
Nitrit (+)

✓ Bei Pyelonephritis hat der Patient meist Fieber und Brennen beim Wasserlassen, während bei Urolithiasis die Schmerzen plötzlich, kolikartig und ohne Fieber.

Bei Pyelonephritis ~~ist~~ sind die Schmerzen dumpf, konstant und in der Flankenregion lokalisiert. Sie werden häufig durch Klopfen verstärkt.

✓ Mittelstrahlurin bedeutet, dass man beim Wasserlassen den mittleren Teil des Urins in einem sauberen Becher auffängt, um Verunreinigungen zu vermeiden.

Das liegt daran, dass

benim nedeni bu / bu sunda sonuçlanır.

Das liegt daran, dass ich krank bin.
(Benim nedeni benim hasta olmam.)

verzichten auf → (Akkus.) Kaçınmak.

Zwangsgedanken – Obsesyon
Zwangshandlungen – Tekrarlayan davranış } Zwangsstörung